

Protocole en phytologie du cancer hormono-dépendant

Définition :

Cancers dont la croissance est stimulée par des hormones sexuelles :

- Sein
- Ovaires
- Endomètre (femme) et prostate (homme).

Dans ce contexte, on évite les plantes à action **« hormone-like » (phyto-oestrogéniques ou progestérone-like)**.

Approche en phytothérapie (priorité : NON hormonale)

1) Terrain & hygiène de vie :

- Évaluer le risque individuel : **surpoids** (aromatisation accrue), **sédentarité**, **tabac**, **ATCD familiaux**, **alimentation**
→ adapter la fréquence/doses des mesures ci-dessous.
- **Diminuer l'inflammation de bas grade** : **curcuma**, **gingembre**, **romarin**, EPA/DHA en prise régulière.

Antioxydants alimentaires/plantes riches en polyphénols (thé vert – catéchines, romarin – acide rosmarinique, etc.).

2) Aide à l'élimination des xéno-oestrogènes :

Crucifères (et graines germées) + alliacées pour soutenir les voies d'élimination hormonale.

3) Plantes « minéralisantes » & soutien général (non hormonales) :

Ortie, prêle, avoine, luzerne/alfalfa, trèfle rouge en infusion (objectif : minéraux ; on n'utilise pas ces plantes ici pour un effet oestrogénique). Posologies de base : 30 g/L pour les feuilles/parties aériennes si utilisées seules; cures régulières.

4) Symptomatologie (exemples non hormonaux) :

- **Sommeil/humeur**
- **Rétention d'eau** : reine-des-prés, piloselle, bouleau.
- **Jambes lourdes** : vigne rouge, petit houx, hamamélis.
- **Reminéralisation/ostéo** : ortie, prêle, alfalfa, tribulus.

Contre-indications & précautions :

À éviter en cas de cancer hormono-dépendant (ou risque élevé), sauf avis spécialisé :

- **Plantes phyto-oestrogéniques** (ou action endocrine marquée) :

Soja (isoflavones concentrées), **Trèfle rouge, sauges** (officinale & sclarée), **Houblon**, **Alfalfa/Luzerne** (attention aussi en maladies auto-immunes), **Armoise** (A. vulgaris), **Actée à grappes noires** (Cimicifuga/Actaea), **Réglisse**, **Dong Quai/Angélique chinoise**, **Shatavari**, **Safran**.

- **Huiles essentielles à visée « hormone-like » à proscrire** : **Sauge sclarée**, **Patchouli**, **Cyprès**, **Niaouli**, **Anis**, **Fenouil**, **Estragon**, **Romarin à verbénone**, **Menthe poivrée** (activation ovarienne).

- **Plantes progestérone-like / modulatrices hypophyso-ovariennes :**

- **Gattilier** (Vitex agnus-castus) et, par extension, complexes **gemmo « progestérone-like » (bourgeons framboisier/pommier)** : à écarter sans encadrement spécialisé.

Cas particuliers :

- **Souci/Calendula**: en interne (emménagogue) à éviter ; usage externe possible si besoin local non hormonal.

- **Maca** et **Éleuthérocoque**: déconseillés (stimulation endocrine/tonique).

- **Houblon**: contre-indiqué par principe de précaution (agoniste ER α/β).

Interactions/tempo thérapeutique :

- **Eau de Quinton**: signalée comme **à éviter pendant et juste après les séances de chimio** (risque de relance immunitaire) → avis de l'oncologue requis.

De façon générale, **éviter toute forme standardisée en isoflavones** (soja/trèfle) et les **plantes hormonales** pendant les phases actives, sauf protocole médical.

Mini-protocole type (piste non hormonale)

- **Détox doux & xéno-oestrogènes**: crucifères (alimentation/germinations) + **tisanes drainantes foie/lymphatiques personnalisées**.

- **Anti-inflammatoire quotidien**: cuisine au **curcuma/gingembre/romarin** + 1 g/j d'EPA + DHA si alimentation pauvre en poissons gras.

- **Reminéralisation/terrain**: **2–3 semaines d'infusions** (ex. 10 g ortie + 10 g prêle + 10 g trèfle rouge/L*), 1–2 tasses/j (objectif : minéraux). *Ici le trèfle est utilisé pour l'apport minéral, pas pour un effet oestrogénique concentré.*